

Свищи — мочеполовые и ректовагинальные

Информация для пациента · Патологическое соединение, вызывающее подтекание мочи, газов или кала

WARWIKI

Свищ (фистула) — патологический канал между двумя органами, которые не должны сообщаться. В области таза он может образоваться между **мочевым пузырём (или мочеточником/уретрой) и влагалищем** — вызывая постоянное подтекание мочи — либо между **прямой кишкой и влагалищем** — с выделением газов или кала через влагалище. Свищи плохо заживают самостоятельно, но поддаются хирургическому лечению.

Об этом состоянии

- **Мочеполовой свищ** (например, пузырно-влагалищный) — непрерывное, неконтролируемое подтекание мочи через влагалище днём и ночью.
- **Ректовагинальный свищ** — выделение газов или кала через влагалище, рецидивирующие инфекции, раздражение.

Симптомы могут быть тягостными и социально изолирующими — но это техническая проблема, имеющая техническое решение, и не является следствием ваших действий.

Причины

- **Операции на органах таза или гинекологические вмешательства** (например, гистерэктомия) — наиболее частая причина во многих странах
- **Роды** — особенно затяжные с обструкцией (ведущая причина в мире)
- **Лучевая терапия**, воспалительные заболевания кишечника, инфекция или (реже) онкологическое заболевание

ТЕРМИНЫ

Свищ (фистула)

Патологический канал между двумя органами.

Пузырно-влагалищный

Свищ между мочевым пузырём и влагалищем.

Ректовагинальный

Свищ между прямой кишкой и влагалищем.

Красящий тест

Введение окрашенной жидкости в пузырь/прямую кишку для определения места утечки.

Цистоскопия

Осмотр мочевого пузыря камерой для выявления отверстия свища.

Лоскут Мартиуса

Лоскут ткани для укрепления места ушивания.

Деривация

Временное отведение мочи или кала на период заживления.

МОЖНО ЛИ ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ? Да — большинство свищей поддаётся лечению, и многие пациенты полностью выздоравливают. Иногда небольшой свежий свищ закрывается самостоятельно при наличии катетера, однако в большинстве случаев требуется плановая операция. Сроки важны: хирурги нередко ждут, пока спадёт воспаление, чтобы добиться наилучшего результата.

Как это диагностируют

- Осмотр, нередко с **красящим тестом** для точного определения места утечки
- **Цистоскопия** и визуализирующие исследования для оценки размера, локализации и причины
- Выявление сопутствующих состояний (последствия облучения, инфекция, воспалительные заболевания кишечника)

Как это лечат

- 1 **Консервативная тактика** — небольшой, недавно возникший мочево́й свищ может закрыться при установленном катетере на несколько недель.
- 2 **Хирургическое ушивание** — закрытие канала через влагалищный или брюшной доступ, как правило, послойно.
- 3 **Тканевый лоскут** — здоровая ткань (например, лоскут Мартиуса) может укрепить место ушивания, особенно после облучения.
- 4 **Временная деривация** — при ряде ректовагинальных свищей кал временно отводится, чтобы обеспечить заживление.

Полезно знать

- До операции защищайте кожу и используйте прокладки; команда поможет с мерами по облегчению дискомфорта.
- Ушивание свищей после **лучевой терапии** сложнее и обычно требует тканевого лоскута.
- После операции может быть установлен катетер и проведена **проверка заживления** перед его удалением.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб, нарастающая боль в области таза
- Признаки инфекции или обильное кровотечение
- После операции: катетер перестал дренировать или подтекание возобновилось

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Свищ — патологическое соединение, вызывающее подтекание мочи (мочеполовой) или выделение газов/кала через влагалище (ректовагинальный).
2. Большинство свищей излечимо: небольшие иногда закрываются с катетером, остальным нужна плановая операция, порой с тканевым лоскутом.
3. Сроки важны: команда может выждать спада воспаления. Сообщайте о температуре, признаках инфекции или возобновлении подтекания после операции.